

TEMA 4.14 • DERMATOLOGÍA

Eritema Pernio

PERFIL EUNACOM 6.01.2.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Eritema Pernio (Perniosis o Sabañones)

El Eritema Pernio es una patología dérmica inflamatoria focalizada, popularmente reconocida en el lenguaje coloquial rústico con la denominación directa de **"Los Sabañones"**.

Fisiopatología Vasomotora

- **Gatillante Directo Primario:** Su causa basal fundamental indetenible resulta de la exposición ambiental reactiva frente a una brutal exposición externa exógena de **FRÍO Agudo o bajas temperaturas**. Desencadenando un fenómeno vasomotor anormal arterial espástico paradójico que disminuye la oxigenación al extremo anatómico limitante dactilar. - **Diferenciación Secundaria Etiológica Excluyente Hospitalaria:** En la extensa proporción este mecanismo reaccionario de "Sabañón idiopático frío" es benigno y puramente Primario. No obstante, al médico EUNACOM se le indica tener profunda alerta roja puesto a que en pacientes de un desarrollo irregular esto podría aflorar atado como un síntoma secundario a **Enfermedades Sistémicas Graves** (Patologías reumatológicas severas latentes del Tejido Conectivo como un temible rancio cruce subyacente y basal encubierto diagnosticando a *Lupus Eritematoso Sistémico*, o *Enfermedad Seca cruzada de Sjögren* que ocultan el perniosis y a desórdenes de Cáncer Hematológico silente basal letal que alteran el colágeno general por paraneoplasia celular, tal como diversas Gammopatías Monoclonales cruzas).

Cuadro Clínico Morfológico Anatómico

- **Rasgos en Placa Tisulares:** Su forma perimetral general es polimorfa variable; debutando más corrientemente como sencillas máculas de **Eritema Violáceo induradas frías**, evolucionando a veces con Pápulas sólidas inflamadas y pudiendo amaurotar al punto grave duro general cruzando en extensos induramientos letales engrosados cruzados en relieve asimilando a densos **"Múltiples Nódulos inflamatorios engrosados cianóticos azules (Sabañón de placa generalizado)"**. - **Cartografía Obligada Focal:** Focaliza anatómicamente con descaro y predilección inmensamente acentuada a depositarse y entumecerse al extremo periférico y estiramientos acrodactilares al descubierto o asediado termicamente como primer foco a **La integridad de los PIES (primer territorio letal basal superior afectado en frecuencia), colapsando el relevo en Las Manipulaciones dísteles de la cara dorsal paralela limitante externa perimetral al frío frontal en MANOS**. Es de casuística escueta y singular infrecuente asfixiar partes orgánicas sin ropas centrales estiradas superiores periféricas asediadas de la cara como Lóbulos de la nariz u pabellones cartilaginosos focales auriculares de Orejas.

Protocolo Terapéutico Dermatológico

- **El Pilar de Oro Manejo Medicamentoso EUNACOM:** Como es una reacción ambiental, es mandatorio a futuro inmediato como rescate general inminente a futuro para evitación del cuadro el **Prohibir sin reservas el desencadenante, abrigando con pasivo escudo físico**

para "Evitar y Bloquear estrictamente la irrupción y embate agudo reaccionario ante el Frío Extremo".

- **Protocolo Diagnóstico de Tamizaje Excluyente y Screening Base:** En protocolos de cuidado actualizado modernos de hoy, no debe descuidarse jamás la investigación basal secundaria por si el paciente cursase silente. Como estándar general de tamizaje cruzado basal a estos idiopáticos "Sabañocillos", se exige de rutina médica secundaria descartar pedir al laboratorio obligatoriamente exámen basal de tamizaje excluyente sistémico celular:
- **1. Los temidos y vitales Screening ANA (Anticuerpos Antinucleares Basales generales cruzados) de reumatología general de colágeno.**
- **2. El screening hematológico basal de leucocitos y sangre total pilar con Hemograma crudo base sin derivación paralela** como despiste de descarte patología hematológica atlántica paralela (sin requerir estudios más especializados o punzo cruzas a menos que este arroje desajustes sistémicos celulares basales).
- **Tratamiento Crítico Severo Excepcional Limitante Farmacológico:** En rarísimos estancamientos patológicos indómitos o letal necrosis vasomotora isquémica rebeldes intratables limitante cruzados que asfixien y necrosan acralmente, asciende prescriptivo obligatorio por descarte derivación al rescate médico general desobstructor del espasmo, al aplicar terapia recetada en vía oral del letal y general asfixiado recetando general paliativo paralelo en píldoras orales con uso del expansor arteriar oral fuerte liso general cruzado celular recitado del Bloqueador general general **El Nifedipino (Vasodilatador de los Canales de Calcio Dihidropiridínico Central)** que barre y suprime general de las disfunciones vasculares.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es el fármaco de elección para los casos graves de eritema pernio?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Eritema Pernio. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El eritema pernio es producido por la exposición al frío con lesiones en pies, manos, orejas y nariz.
- Las lesiones son eritematosas violáceas pruriginosas que empeoran con el calor.
- El eritema pernio puede ser secundario a lupus u otras enfermedades sistémicas.
- Siempre debe solicitarse ANA para descartar enfermedad del tejido conectivo subyacente.
- El hemograma es necesario para descartar causas hematológicas en el eritema pernio.
- El nifedipino como bloqueador de calcio dihidropiridínico es el tratamiento en casos graves.
- La principal medida preventiva y terapéutica es evitar la exposición al frío y la humedad.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ERITEMA PERNIO)

PREGUNTA 1

¿Cuál es el fármaco de elección para los casos graves de eritema pernio?

- A) El ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario para mejorar la microcirculación
- B) El nifedipino que es un bloqueador de canales de calcio dihidropiridínico vasodilatador
- C) Los corticoides orales para suprimir la respuesta inflamatoria sistémica
- D) Los antihistamínicos H1 no sedantes para controlar el prurito intenso
- E) La warfarina oral para prevenir los fenómenos trombóticos asociados al vasoespasma

PREGUNTA 2

¿Qué estudio siempre debe solicitarse ante un eritema pernio para descartar causa secundaria?

- A) Perfil tiroideo con TSH y T4 libre para descartar hipotiroidismo
- B) Anticuerpos antinucleares ANA y hemograma para descartar enfermedad sistémica
- C) Hemocultivos seriados para descartar bacteriemia como causa del cuadro
- D) Biopsia de piel con inmunofluorescencia para confirmar el diagnóstico
- E) Prueba de parches para identificar posibles alérgenos de contacto

PREGUNTA 3

¿Qué característica clínica empeora con el calor en el eritema pernio?

- A) Las lesiones ampollosas tienden a romperse con el aumento de temperatura
- B) El prurito y la sensación urente empeoran cuando el paciente se calienta
- C) El eritema se extiende hacia zonas no expuestas al frío con el calor
- D) La vasodilatación produce más depósito de complejos inmunes en la piel
- E) Las costras se ablandan y aumentan de tamaño con el aumento térmico

RESUMEN: ERITEMA PERNIO

El eritema pernio, también llamado sabañones o perniosis, es una enfermedad causada por la exposición prolongada al frío y la humedad que produce un vasoespasma y posterior vasodilatación reactiva. Se caracteriza por lesiones eritematosas, edematosas y violáceas en forma de pápulas y máculas que aparecen principalmente en los pies, seguidos por las manos, las orejas y la nariz. Las lesiones son pruriginosas y dolorosas al tacto, y empeoran con el calor. El eritema pernio puede ser primario, sin causa subyacente, o secundario, asociado a enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso, otras enfermedades del tejido conectivo, enfermedades hematológicas o vasculitis. Por esto, ante un eritema pernio siempre debe solicitarse un perfil de anticuerpos antinucleares o ANA para descartar enfermedad del tejido conectivo, y un hemograma para descartar causas hematológicas. El tratamiento incluye evitar la exposición al frío y en los casos graves el nifedipino, que es un bloqueador de los canales de calcio dihidropiridínico, actúa como vasodilatador.